UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

(Thérapeutique)
(Mise en place AVK chez une patiente avec SAPL)
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Barbry Emma **Date de rédaction : décembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N°249 – Prescription et suivi d'un traitement par anticoagulant et/ou anti-antiagrégant SDD-248

Domaine de compétence n°1 : stratégie pertinente de prise en charge

Domaine de compétence n°1 : Éducation/prévention

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Prescrire et justifier l'indication et le choix d'un traitement anti thrombotique

2- Éduquer le patient sous anticoagulant au long cours : suivi de ses INR, suivi biologique, complications, adhésion au traitement

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) : Item 330 Prescription et surveillance des classes de médicaments les plus courantes chez l'adulte et chez l'enfant, hors anti-infectieux (voir item 177). Connaître le bon usage des principales classes thérapeutiques

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (femme) (30 ans)

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 table, 2 chaises

Instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synopsis :

Ex : Vous êtes une jeune femme de 30 ans. À la suite d'une embolie pulmonaire, un bilan a été réalisé. Le médecin de médecine interne a posé le diagnostic de SAPL et son remplaçant vous voit à ce jour pour vous prescrire un traitement anticoagulant.

Votre médecin de médecine interne va vous interroger.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Mme Dumont Age : 30 ans Fiancée, pas d'enfants
Antécédents	Médicaux : embolie pulmonaire, phlébite, lupus systémique Obstétricaux : une fausse couche Chirurgicaux : dent de sagesse à ses 18 ans
Médicaments actuels/ Toxiques	*Contraception oestroprogestative, tabac, automédication par AINS pour des maux de tête*
Etats d'esprit/ comportement	Posture : assise Angoisse : faible
Déroulement du scénario	Vous êtes assise Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Ex : « On m'a diagnostiqué une maladie suites à mon embolie pulmonaire… ça s'appelle un SAP quelque chose…. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais on m'a dit de venir voir pour mettre en place des anticoagulants »* Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci- dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement.

Questions à poser	Après l'explication de la raison de la mise en place de l'anticoagulation, quand le D4 vous demande si vous avez des questions : **QUESTION 1 : « D'accord, je comprends pourquoi je dois prendre le traitement. Mais, rassurez-moi, ce sera comme pour ma mamie après sa prothèse de hanche ; une piqure dans la cuisse quelques temps par l'infirmière et ce sera réglé ? »** **QUESTION 2 : « Docteur, tant qu'on y est-ce que vous pouvez me prescrire de l'ibuprofène ? j'ai des maux de tête terribles en ce moment »**

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose.
Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Avez-vous des antécédents médicaux ?	Oui j'ai un lupus et j'ai déjà fait une phlébite qui est devenue une embolie pulmonaire … la poisse !
Avez-vous des antécédents familiaux ?	Pas que je sache
Avez-vous des antécédents chirurgicaux ?	Je me suis faite opérée de mes dents de sagesse, mais c'était il y a longtemps
Avez-vous des antécédents obstétricaux ?	J'ai eu malheureusement une fausse couche
Avez-vous des allergies ?	Non aucune
Avez-vous des traitements ?	Non à part la pilule et l'hydroxychloroquine pour mon lupus…
Avez-vous déjà pris des AINS ou de l'aspirine ?	Il m'arrive de prendre de temps en temps de l'ibuprofène quand j'ai des migraines
Buvez-vous de l'alcool ?	Non je n'aime pas trop ça
Fumez-vous ?	Oui 2 cigarettes par jour à peu près
Avez-vous un projet de grossesse ?	Oui dans quelques années on aimerait bien retenter notre chance et avoir un enfant

Instructions à l'étudiant

Vous êtes médecin hospitalier de médecine interne et vous remplacez votre confrère. Vous recevez Madame Dumont, 30 ans, nouvellement diagnostiquée d'un SAPL. Vous la voyez à ce jour pour mettre en place une anticoagulation par anti-vitamine K.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Justifier l'anticoagulation à la patiente
2. Répondre aux 2 questions de la patiente
3. Organiser la mise en place et la surveillance nécessaire à l'anti-vitamine K

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Explique que la SAPL est une maladie chronique	
Explique le risque de thrombose	
Explique le risque de complications obstétricales	
Énonce la nécessité d'AVK	
Explique que les AVK fluidifient le sang	
Tache 2	
Informe la prise per os	
Informe que les AVK seront à prendre à vie	
Préconise l'arrêt de l'automédication par AINS	
Justifie l'arrêt en énonçant les interactions médicamenteuses	
Tache 3	
Évoque la surveillance par INR	
Énonce la surveillance clinique + biologique de la fonction hépatique *(OK si 1/2)*	
Précise la nécessité d'observance	
Énonce les effets indésirables : hémorragie	
Enonce la nécessité des HBPM pendant quelques jours	
Explique la nécessité des HBPM par l'action anticoagulante des AVK prenant plusieurs jours à se mettre en place	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS	
APTITUDE À QUESTIONNER	